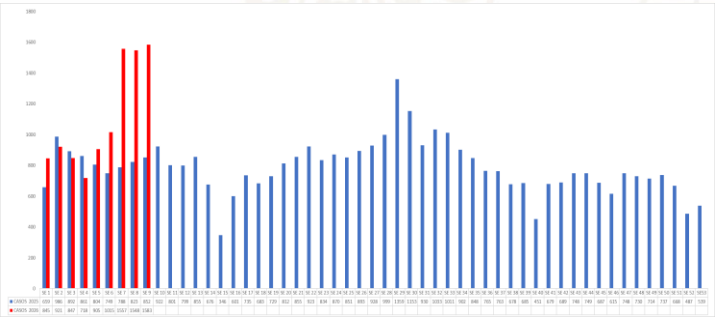
DIARREAS SE#9

NOTIFICANTE	DIARREA SE 9	DIARREA ACUM 2025	DIARREA ACUM 2026	TASA DE INCIDENCIA ACUM.	TASA DE INCIDENCIA SE 9	TASA DE MORTALIDAD
CIS	739 (46%)	7,414	10,044	731 casos x c/100mil hab.	115 casos x c/100mil hab.	0
SPU	164 (12%)					
HOSP.	680 (42%)					
TOTAL	1,583 (100%)					

Población DC Año 2026= 1,372,705

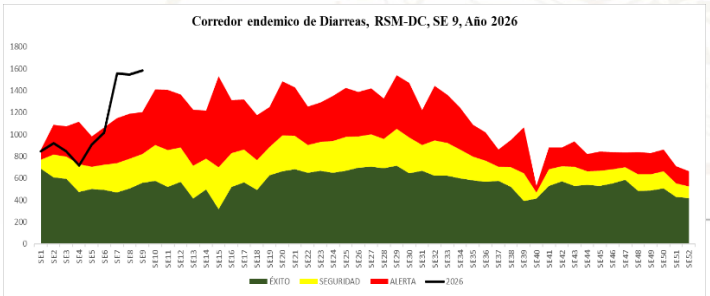
Figura No. 1 Comparativo Notificación de Casos Diarreas/Síndrome Diarreico Agudo con y sin Deshidratación, RSMDC, S.E. 9, Año 2025- 2026.



Fuente: Telegrama AGI RSMDC AÑO 2025-2026

A la SE#9 del año 2026 se notifica (n=**1,583**) casos de diarrea en comparación al año 2025 con (n=**852**) con un aumento del 26 % por ciento para el año 2026.

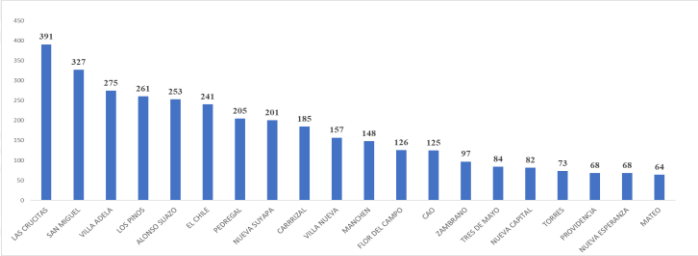
Figura No. 2 Corredor Epidemiológico de Diarreas, RSMDC, SE 9 Año 2026.



Fuente: Telegrama AGI-UVS RSMDC Año 2022-2026

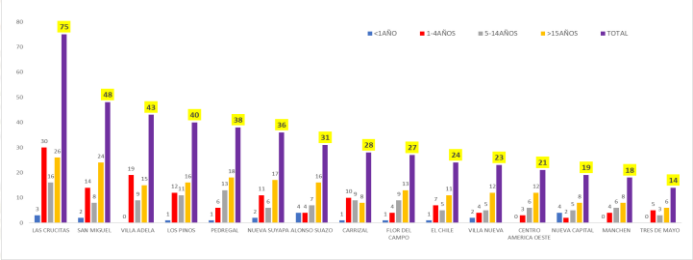
Durante la Semana 9 para el año 2026 se reportan 1548 casos de diarrea y 852 casos para la misma semana epidemiológica durante el año 2025, 696 casos más para el año 2026. La línea de tendencia es ascendente, se ubica en zona de epidemia.

Notificación Casos ambulatorios acumulados Diarreas/Síndrome Diarreico Agudo con y sin Deshidratación 1eros 20 CIS RSMDC SE 9, Año 2026.



Fuente: Notificación, Varios AGI RSMDC AÑO 2026

Notificación Casos Ambulatorios Diarreas/Síndrome Diarreico Agudo con y sin Deshidratación 1eros 15 CIS Vs Rango Etario, RSMDC SE 9, Año 2026.

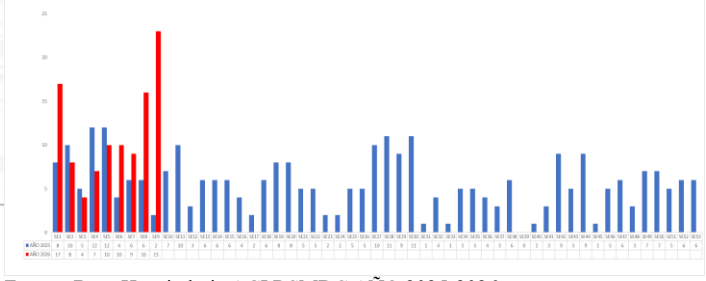


Fuente: Notificación, Varios AGI RSMDC AÑO 2026

HOSPITALARIA/DIARREAS

Ingreso hospitalario acumulado hasta la SE 9	
Año 2025	*65 ingresos*
Año 2026	*104 ingresos*
aumento del 37 % para el año 2026	

Figura No. 3 Comparativo Ingresos Hospitalarios Diarreas/Síndrome Diarreico Agudo con y sin Deshidratación RSMDC S.E. 9, Año 2025- 2026

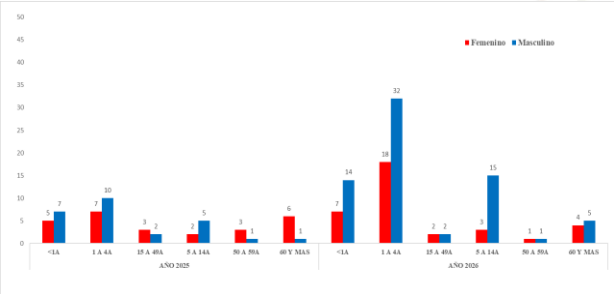


Fuente: Base Hospitalaria AGI RSMDC AÑO 2025-2026

A la SE#9 del año 2026 se notifican (n=**23**) ingresos hospitalarios por diarreas/ síndrome diarreico agudo con o sin deshidratación con un aumento del 91 % para el año 2026, en comparación al año 2025 con (n=**2)** ingresos hospitalarios a la misma semana epidemiológica.

Hasta la SE 9 del año 2026 la mayor notificación de ingresos hospitalarios según hospital notificador lo representa con un 53% (n=56) el IHSS y seguido del HEU con un 33 % (n=35).

Figura No. 4 Comparativo Rango etario Vs. Sexo Diarreas/Síndrome Diarreico Agudo con y sin Deshidratación RSMDC S.E. 9, Año 2025-2026



Fuente: Base Hospitalaria AGI RSMDC AÑO 2025-2026

Para el año 2026 a la SE9 el sexo que más predomina en el ingreso hospitalario por diarreas es el masculino representando el 50 %, existe mayor número de ingresos hospitalarios en el rango de ***1-4 años*** , al igual que el año 2025 .

Tabla No. 1 Notificación ingreso hospitalario según CIS diarreas/síndrome diarreico agudo con y sin deshidratación RSMDC S.E. 9, Año 2026

CIS	SE6	SE7	SE8	SE9	Total
VILLA_NUEVA	1		2	4	7
CAO	1	1	2	2	6
CHILE_EL		2		3	5
SAN_MIGUEL	1		1	2	4
VILLA_ADELA	1	2	1		4
NUEVA_SUYAPA		1	2		3
CRUCITAS_LAS		1		1	2
SAN_BENITO			1	1	2
DIVANNA_LA			1	1	2
ALEMANIA_LA			1	1	2
MATEO	2				2
CUESTA_LA	1			1	2
MANCHEN_EL			1	1	2
_21_DE_FEBRERO				1	1
DIVINA_PROVIDENCIA	1				1
TORRES_LAS				1	1
_3_DE_MAYO	1				1
YAGUACIRE	1				1
CRUZ_ROJA				1	1
TIZATILLO			1		1
RIO_ABAJO			1		1
VENTA_NORTE_LA		1			1
CARRIZAL_EL			1		1
EDEN_EL				1	1
SAN_FRANCISCO			1		1
(en blanco)		1			1
BOSQUE_EL				1	1
TAMARA				1	1
Total	**10**	**9**	**16**	**23**	**58**

Fuente: Base Hospitalaria AGI RSMDC AÑO 2026

Tabla No. 2 Notificación ingreso hospitalaria por CIS según rango de edad diarreas/Síndrome diarreico agudo con y sin deshidratación RSMDC S.E. 9, Año 2026

CIS	<1A	1 A 4A	15 A 49A	5 A 14A	Total
VILLA_NUEVA		2		2	4
CHILE_EL	1	1	1		3
CAO				2	2
SAN_MIGUEL		1		1	2
BOSQUE_EL				1	1
EDEN_EL	1				1
DIVANNA_LA	1				1
SAN_BENITO	1				1
MANCHEN_EL		1			1
TAMARA	1				1
ALEMANIA_LA	1				1
CRUCITAS_LAS		1			1
TORRES_LAS		1			1
CRUZ_ROJA				1	1
_21_DE_FEBRERO		1			1
CUESTA_LA	1				1
Total	**7**	**8**	**1**	**7**	**23**

Fuente: Base Hospitalaria AGI RSMDC AÑO 2026

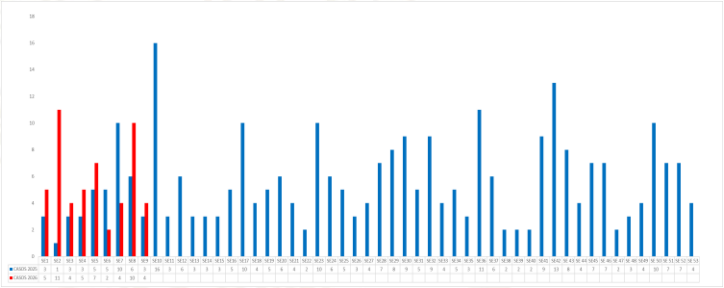
MORTALIDAD /DIARREAS Hasta la SE 9 no se reportan defunciones.

DISENTERIAS SE#9

NOTIFICANTE	DISENTERIA SE 9	DISENTERIA ACUM 2025	DISENTERIA ACUM 2026	TASA DE INCIDENCIA ACUM.	TASA DE INCIDENCIA SE9	TASA DE MORTALIDAD
CIS	0 (0%)	39	49	3 casos x c/100mil hab.	1 caso x c/100mil hab.	0
SPU	0 (0%)					
HOSP.	4 (100%)					
TOTAL	4 (100%)					

Población DC Año 2026= 1,372,705

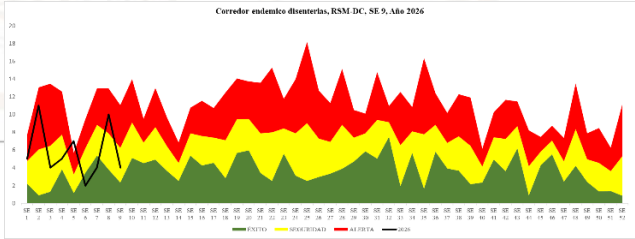
Figura No. 1 Comparativo notificación casos de disenterías ambulatorio, RSMDC, S.E. 9, Año 2025-2026.



Fuente: Telegrama AGI RSMDC AÑO 2025-2026

Hasta la SE9 del año 2026 se notifica un acumulado de casos de disenterías de (n=**4**) representando un aumento del 25 % con respecto a los casos acumulados a la misma SE del año 2025 los cuales fueron (n=**3**).

Figura No. 2 Corredor epidemiológico de disenterías, RSMDC, SE 9 Año 2026.



Fuente: Telegrama AGI-UVS RSMDC Año 2026

Durante la semana 9 para el año 2026 se reportan 4 casos de disenterías y 3 casos para la misma semana epidemiológica durante el año 2025, 1 casos más para el

año 2026. La línea de tendencia es ascendente, se ubica en zona de alerta.

HOSPITALARIA/DISENTERIAS

A la SE#9 del año 2026 no se notifican casos de ingreso hospitalario por disenterías; Así mismo para la misma SE año 2024 tampoco se notifican casos de ingreso hospitalario.

MORTALIDAD /DISENTERIAS

Hasta la SE 9 no se ha notificado una defunción por Disentería.

ROTAVIRUS SE#9

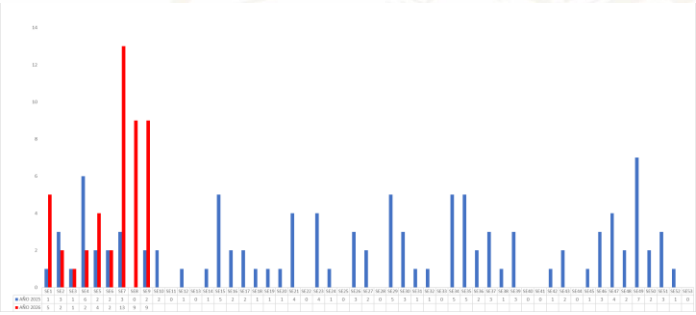
NOTIFICANTE	Notificación ROTAVIRUS SE 9	Notificación ROTAVIRUS ACUM 2025	Notificación ROTAVIRUS ACUM 2026	TASA DE INCIDENCIA SE9	TASA DE MORTALIDAD
HOSP.	9	20	47	Total, de casos (+) en la SE 9= 1 Tasa de 0.07	0

Población DC Año 2026= 1,372,705

Situación epidemiológica rotavirus en el Distrito Central SE#9 Año 2026:

La mayor notificación de casos corresponde a los Hospitales con un 100%, siendo **vigilancia centinela** en los menores de 5 años para el HEU un 62% (n=36) y el restante porcentaje con un 26 % IHSS (n=15) .

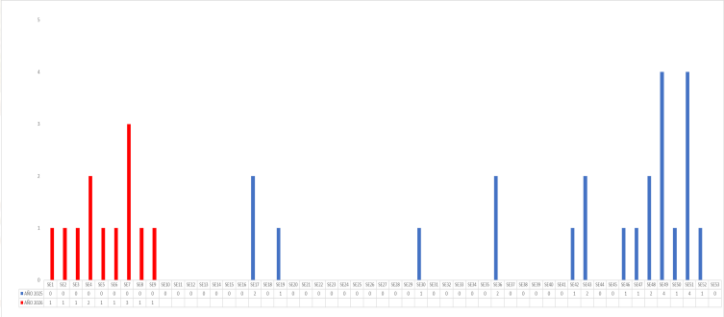
Figura No. 1 Comparativo notificación de casos sospechosos de rotavirus, RSMDC, S.E. 9, Año 2025-2026.



Fuente: Telegrama AGI RSMDC AÑO 2025-2026

Hasta la Semana epidemiológica (SE) 9 del año 2026, se ha notificado un acumulado de (n=47) casos sospechosos de rotavirus, lo que representa un aumento del 57 % en comparación con los casos acumulados en la misma SE del año 2025, registrándose (n=20) casos .

HOSPITALARIA/ROTAVIRUS



Hasta la SE9 del año 2026, se notifican (n=12) casos confirmados de rotavirus por ingresos hospitalario 2dario al diagnóstico de diarrea o síndrome gastroentérico . Del mismo modo, a la SE 9 del año 2025, no se reportaron casos confirmados de rotavirus (n=0) en menores de 5 años. A la SE 9 del año 2026 se notifica un caso para rotavirus, para el año 2025 no se notificaron casos .

Figura No. 4 Comparativo rango etario Vs. sexo rotavirus RSMDC S.E. 9, Año 2025- 2026

A la SE9 del año 2026, se notifica (n=12) casos confirmados de rotavirus . En comparación a la SE 9 del año 2025, no se reportaron casos confirmados de rotavirus (n=0) , siendo todos los casos en menores de 5 años.

MORTALIDAD /ROTAVIRUS

Hasta la Fecha no se ha notificado una defunción por Rotavirus.

FIEBRE TIFOIDEA SE#9

NOTIFICANTE	FIEBRE TIFOIDEA ACUM	FIEBRE TIFOIDEA SE9	TASA DE INCIDENCIA.	TASA DE MORTALIDAD
CIS	**0**	0	0	0
CLIPERS		0		
HOSPITALES		0		
TOTAL		0		

Población DC Año 2026= 1,372,705

Situación epidemiológica Fiebre Tifoidea en el Distrito Central SE#9 Año 2026:

A la Semana epidemiológica (SE) 9 del año 2026, no se notifican casos confirmados de fiebre tifoidea (n=0) relacionados con ingresos hospitalarios. Del mismo modo, en la SE 9 del año 2025, tampoco se reportaron casos confirmados de fiebre tifoidea (n=0).

COLERA SE#9

NOTIFICANTE	COLERA 2026	TASA DE MORBILIDAD DC Por cada 100,000 Hab	TASA DE MORTALIDAD DC
HOSPITALES	0	**0**	**0**
CIS/UAPS	0		
CLIPER	0		
TOTAL	**0**		

Población DC Año 2026= 1,372,705

Situación epidemiológica Colera en el Distrito Central SE#9 Año 2026:

Hasta la SE9 del año 2026 no se notifican casos de Colera (n=**0)** con respecto a los casos acumulados a la misma SE del año 2025 los cuales fueron (n=**0**) tampoco se presentaron casos de colera.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, hasta el 21 de diciembre de 1991, Honduras había notificado 17 casos de cólera, sin reportar defunciones.

En los años siguientes, el país continuó registrando casos de cólera, aunque en menor medida en comparación con otras naciones centroamericanas. En el año 1992, Honduras reportó 407 casos confirmados y 17 defunciones, con una tasa de incidencia de 8,09 por 100.000 habitantes y una letalidad del 4,18%.

Desde mediados de la década de 1990, la incidencia de cólera en Honduras disminuyó significativamente, y el país no ha registrado brotes importantes en las últimas décadas.

Para la SE33 año 2025 se reporto en el municipio de **Tatahuicapan**, Veracruz, se reportó una serie de casos de vómito, diarrea y fiebre desde el fin de semana anterior, con atención médica a numerosos afectados provenientes de tres barrios. Esta situación derivó en la saturación del centro de salud local y en el traslado de pacientes al Hospital IMSS Bienestar.

Aunque inicialmente se sospechó de un brote de cólera, la Secretaría de Salud aclaró que los casos correspondían a **infecciones diarreicas por Escherichia coli (E. coli)**, y no por cólera. Se manejaron más de **300 pacientes**, de los cuales **135** ya estaban completamente recuperados.